泉州市超声检查类等四批立项指南解读

泉州市医疗保障局

2025年11月

中国医疗保障
CHINA HEALTHCARE SECURITY

目录

CONTENTS

1 中医骨伤类立项指南

2 中医特殊疗法类立项指南

3 超声检查类立项指南

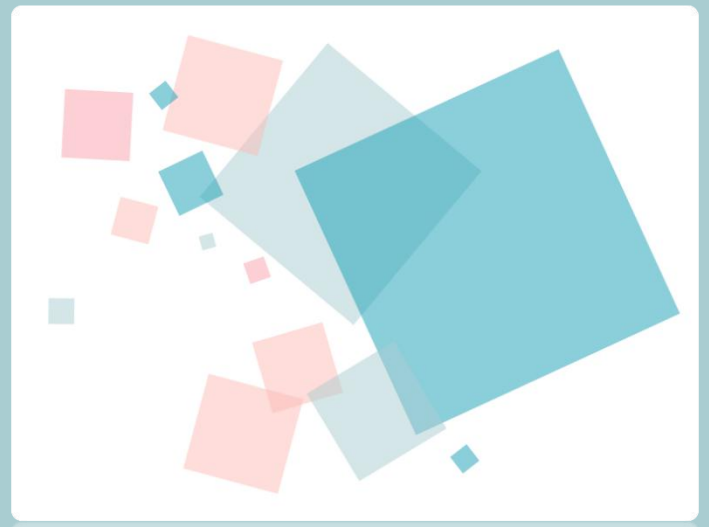
4 泌尿系统部分立项指南

中国医疗保障
CHINA HEALTHCARE SECURITY

PART 1

中医骨伤类立项指南

1. 中医骨伤类立项指南



2024年10月，国家医保局印发《中医骨伤类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，设立9个中医骨伤类项目。根据国家医保局落实立项指南工作安排，2025年9月3日，省医保局出台了《福建省医疗保障局关于规范整合中医骨伤类和中医特殊疗法类医疗服务价格项目的通知》（闽医保〔2025〕60号），规范整合中医骨伤类医疗服务价格项目，同时停用我省关节脱位手法整复术等27项相关价格项目，并要求各地按不高于省属公立医院价格原则制定本地具体项目价格，11月1日起执行。

1-1. 中医骨伤类立项指南总说明

中国医疗保障
CHINA HEALTHCARE SECURITY

1

本类别以中医骨伤为重点，按照中医骨伤治疗方式的服务产出设立价格项目。医疗机构、医务人员实施中医骨伤过程中有关创新改良，采取“现有项目兼容”的方式简化处理，直接按照对应的整合项目执行即可。

2

“价格构成”指项目价格应涵盖的各类资源消耗，用于确定计价单元的边界，是各级医疗保障部门制定调整项目价格考虑的测算因子，**不应作为临床技术标准理解，不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求**，价格构成中包含，但个别临床实践中非必要、未发生的，无需强制要求公立医疗机构减计费用。所列“设备投入”包括但不限于操作设备、器具及固定资产投入。

1-1. 中医骨伤类立项指南总说明

3

“加收项”指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时，确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项。

4

“扩展项”指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时，只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项，子项的价格按主项目执行。

5

“基本物耗”指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品，包括但不限于各类消杀灭菌用品、标签、储存用品、清洁用品、个人防护用品、垃圾处理用品、冲洗液、润滑剂、棉球、棉签、纱布（垫）、护（尿）垫、手术巾（单）、治疗巾（单）、中单、治疗护理盘(包)、手术包、注射器、防渗漏垫、悬吊巾、压垫、棉垫、可复用的操作器具、各种针具刀具等。基本物耗成本计入项目价格，不另行收费。除基本物耗以外的其他耗材，按照实际采购价格零差率另行收费。

1-1. 中医骨伤类立项指南总说明

切记：不是每节椎体（每个小关节）分别计价，一次治疗涉及多个椎体（小关节）的，按相关计价部位收费一次。

6 “每关节”是指单个大关节（肩、肘、腕、髋、膝、踝）、**颈椎、胸椎、腰椎、**单侧手掌部关节、单侧足部关节、单侧颞颌关节、单侧肩锁关节、胸锁关节。

7 “儿童”是指6岁及以下未成年人。

8 涉及“包括……”“……等”的，属于开放型表述，所指对象不仅局限于表述中列明的事项，也包括未列明的同类事项。

1-2. 中医骨伤类立项指南项目解读

1. 规范简化收费，提高项目兼容性。

①各部位的脱位或紊乱（骨折或韧带损伤）整复，均按对应项收费。

②将临床开展的“借助辅助器械复位”的操作纳入服务产出，解决原先此类操作无法收费的问题。

立项指南价格项目					原价格项目				
项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明	项目名称	计价单位	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
手法整复术（关节脱位）	通过手法（或辅助器械）使脱位或紊乱关节复位。	所定价格涵盖摆位、整复、包扎、必要时固定等步骤，以及必要时使用辅助器械所需的人力资源和基本物质资源消耗。	每关节	指（趾）间关节脱位下颌关节脱位、桡骨头半脱位减半收取。	关节脱位手法整复术	次	405	365	310
					关节脱位手法整复术（桡骨头脱位）	次	270	243	207
					麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗	次	900	855	770
手法整复术（骨伤）	通过正骨手法（或辅助器械）使骨折或韧带损伤复位。	所定价格涵盖摆位、整复、包扎、必要时固定等步骤，以及必要时使用辅助器械所需的人力资源和基本物质资源消耗。	每处骨折	掌（跖）、指（趾）骨折减半收取。	骨折手法整复术	次	430	410	370
					骨折手法整复术（骨折合并脱位）	次	645	615	555

★“必要时固定”指配合手法整复（过程中）而使用的固定，不得单独收费，如绷带包扎固定，并非整复后的夹板固定等外固定方式。

1-2. 中医骨伤类立项指南项目解读

立项指南价格项目								原价格项目				
项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）	项目名称	计价单位	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
手法整复术（关节脱位）	通过手法（或辅助器械）使脱位或紊乱关节复位。	所定价格涵盖摆位、整复、包扎、必要时固定等步骤，以及必要时使用辅助器械所需的人力资源和基本物质资源消耗。	每关节	指（趾）间关节脱位、下颌关节脱位、桡骨头半脱位减半收取。	495	446	380	关节脱位手法整复术	次	405	365	310
								关节脱位手法整复术（桡骨头脱位）	次	270	243	207
								麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗	次	900	855	770
手法整复术（指（趾）间关节脱位、下颌关节脱位、桡骨头半脱位）			每关节		247.5	223	190	关节脱位手法整复术（下颌关节脱位）	次	202.5	182.5	155
								关节脱位手法整复术（指（趾）间关节脱位）	次	202.5	182.5	155
								关节脱位手法整复术（桡骨头半脱位）	次	162	146	124

需要注意的点：

①行腰椎间盘突出症大手法治疗，按立项后项目“手法整复术（关节脱位）”收费，**治疗过程需麻醉的，麻醉费可另行计费。**

②医疗机构可自行下浮收费标准。（部分医疗机构反映小关节脱位的手法整复价格偏高）

1-2. 中医骨伤类立项指南项目解读

1. 规范简化收费，提高项目兼容性。

①各部位的中医骨折内固定，均按此项收费。

②各种中医内固定操作方式，均按此项收费。

立项指南价格项目					原价格项目				
项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明	项目名称	计价单位	价格(市级)	价格(县级)	价格(基层)
中医复位内固定术	使用各种针具、钉具，以内固定方式复位固定骨折部位。	所定价格涵盖摆位、消毒、进针、牵拉复位、撬拨、包扎固定等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	每处骨折		骨折经皮钳夹复位术	次	380	360	325
					骨折闭合复位经皮穿刺（钉）内固定	次	970	920	830
					骨折闭合复位经皮穿刺（钉）内固定（四肢长骨干）	次	1065	1015	910
					骨折闭合复位经皮穿刺（钉）内固定（近关节）	次	1065	1015	910
					骨折橇拨复位术	次	380	360	325

1-2. 中医骨伤类立项指南项目解读

中国医疗保障 CHINA HEALTHCARE SECURITY

2. 规范计价单位，尊重临床实际。

临床上不排除存在多关节脱位（或多部位骨折）的情况，为体现收费合理性，将手法整复术（关节脱位）计价单位规范为“每关节”；手法整复术（骨伤）计价单位规范为“每处骨折”。

立项指南价格项目					原价格项目				
项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明	项目名称	计价单位	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
手法整复术（关节脱位）	通过手法（或辅助器械）使脱位或紊乱关节复位。	所定价格涵盖摆位、整复、包扎、必要时固定等步骤，以及必要时使用辅助器械所需的人力资源和基本物质资源消耗。	每关节	指（趾）间关节脱位、下颌关节脱位、桡骨头半脱位减半收取。	关节脱位手法整复术	次	405	365	310
					关节脱位手法整复术（桡骨头脱位）	次	270	243	207
					麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗	次	900	855	770
手法整复术（骨伤）	通过正骨手法（或辅助器械）使骨折或韧带损伤复位。	所定价格涵盖摆位、整复、包扎、必要时固定等步骤，以及必要时使用辅助器械所需的人力资源和基本物质资源消耗。	每处骨折	掌（跖）、指（趾）骨折减半收取。	骨折手法整复术	次	430	410	370
					骨折手法整复术（骨折合并脱位）	次	645	615	555

1-2. 中医骨伤类立项指南项目解读

3. 区分难度差异，体现劳务价值。

尊重临床实际，对于技术难度和风险程度较高、人力资源消耗较多的情况，设置“复杂”的收费项目，并明确属于“复杂”的具体情况。

项目名称	立项指南价格项目					原价格项目				
	项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明	项目名称	计价单位	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
手法整复术（关节脱位）	手法整复术（复杂关节脱位）	通过手法（或辅助器械）使脱位复杂关节复位。	所定价格涵盖摆位、整复、包扎、必要时固定等步骤，以及必要时使用辅助器械所需的人力资源和基本物质资源消耗。	每关节	“复杂关节脱位”指寰枢椎、髋关节骨盆等关节脱位以及陈旧性脱位。	关节脱位手法整复术（陈旧性脱位）	次	810	730	620
						关节脱位手法整复术（髋关节脱位）	次	810	730	620
手法整复术（骨伤）	手法整复术（复杂骨伤）	通过正骨手法（或辅助器械）使复杂骨折或韧带损伤复位。	所定价格涵盖摆位、整复、包扎、必要时固定等步骤，以及必要时使用辅助器械所需的人力资源和基本物质资源消耗。	每处骨折	“复杂骨伤”指脊柱、骨盆、关节内等骨折以及陈旧性粉碎性骨折。	骨折手法整复术（陈旧性骨折）	次	860	820	740

1-2. 中医骨伤类立项指南项目解读

中国医疗保障 CHINA HEALTHCARE SECURITY

4. 明确计价说明，规范临床收费。

①明确减收的具体情况，并设置收费项目，但与主项共有一个结算编码（项目代码）。

②明确“手法松解术”不得与同部位中医推拿同时收费。（治疗目的上存在重叠，但手法松解术侧重于对局部组织粘连的精准松解，推拿则侧重于通过手法作用于经络穴位。）

项目代码	项目名称	计价单位	计价说明
014300000010000	手法整复术（关节脱位）	每关节	指（趾）间关节脱位、下颌关节脱位、桡骨头半脱位减半收取。
014300000010000	手法整复术（指（趾）间关节脱位、下颌关节脱位、桡骨头半脱位）	每关节	
014300000030000	手法整复术（骨伤）	每处骨折	掌（跖）、指（趾）骨折减半收取
014300000030000	手法整复术（掌（跖）、指（趾）骨折）	每处骨折	
014300000050000	小夹板固定术	部位	掌（跖）、指（趾）骨折的小夹板固定按30%收取
014300000050000	小夹板固定术（掌（跖）、指（趾）骨折）	部位	
014300000080000	手法松解术	次	不与同部位中医推拿同时收费。关节错缝术参照手法松解术并市级按100元收取、县级按95元收取、基层按85元收取。
014300000080000	手法松解术（关节错缝术）	次	

1-2. 中医骨伤类立项指南项目解读

5. 保留传统项目，体现中医特色。

规范整合原有中医传统项目予以保留，明确“通过小夹板等各种外固定方式……”均可对应“小夹板固定术”收费；

明确复诊时“对小夹板等（各种）外固定装置进行调整”均可对应“小夹板调整术”收费。

立项指南价格项目					原价格项目				
项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明	项目名称	计价单位	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
小夹板固定术	通过小夹板等各种外固定方式对骨折部位进行包扎固定。	所定价格涵盖摆位、固定等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	部位	掌（跖）、指（趾）骨折的小夹板固定按30%收取	骨折夹板外固定术	次	340	325	290
					骨折夹板外固定术（叠瓦氏外固定术）	次	340	325	290
					骨折夹板外固定术（8字绷带外固定术）	次	340	325	290
小夹板调整术	根据患者复诊情况对小夹板等外固定装置进行调整。	所定价格涵盖观察、调整等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	部位		外固定调整术	次	50	48	40
					外固定调整术（骨折外固定架调整）	次	50	48	40
					外固定调整术（外固定夹板调整）	次	50	48	40

★同一患处，进行手法整复后，需再进行夹板外固定的，可同时收取“小夹板固定术”。

中国医疗保障
CHINA HEALTHCARE SECURITY

PART 2

中医特殊疗法类立项指南

2. 中医特殊疗法类立项指南

2024年10月，国家医保局印发《中医特殊疗法类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，设立6个中医特殊疗法类项目。根据国家医保局落实立项指南工作安排，2025年9月3日，省医保局出台了《福建省医疗保障局关于规范整合中医骨伤类和中医特殊疗法类医疗服务价格项目的通知》（闽医保〔2025〕60号），规范整合中医特殊疗法类医疗服务价格项目，同时停用我省小针刀治疗11项相关价格项目，并要求各地按不高于省属公立医院价格原则制定本地具体项目价格，11月1日起执行。

2-1. 中医特殊疗法类立项指南总说明

1

本类别以中医特殊疗法为重点，按照中医特殊疗法治疗方式的服务产出设立价格项目。医疗机构、医务人员实施中医特殊疗法过程中有关创新改良，采取“现有项目兼容”的方式简化处理，直接按照对应的整合项目执行即可。

2

“价格构成”指项目价格应涵盖的各类资源消耗，用于确定计价单元的边界，是各级医疗保障部门制定调整项目价格考虑的测算因子，不应作为临床技术标准理解，不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求，价格构成中包含，但个别临床实践中非必要、未发生的，无需强制要求公立医疗机构减计费用。所列“设备投入”包括但不限于操作设备、器具及固定资产投入。

3

“加收项”指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时，确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项。

4

“扩展项”指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时，只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项，子项的价格按主项目执行。

2-1. 中医特殊疗法类立项指南总说明

5. “基本物耗”指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品，包括但不限于各类消杀灭菌用品、标签、储存用品、清洁用品、个人防护用品、垃圾处理用品、冲洗液、润滑剂、棉球、棉签、纱布（垫）、护（尿）垫、手术巾（单）、治疗巾（单）、中单、治疗护理盘(包）、手术包、注射器、防渗漏垫、悬吊巾、压垫、棉垫、可复用的操作器具、各种针具刀具等。基本物耗成本计入项目价格，不另行收费。除基本物耗以外的其他耗材，按照实际采购价格零差率另行收费。

6. “针刀（钩活）疗法”的计价单位为“部位”，具体指：头部、颈部、胸部、腰部、腹部、臀部、四肢大关节及手足，一次部位多次进针的不叠加收费。

7. “儿童”是指6岁及以下未成年人。

8. 涉及“包括……”“……等”的，属于开放型表述，所指对象不仅局限于表述中列明的事项，也包括未列明的同类事项。

2-2. 中医特殊疗法类立项指南项目解读

1. 规范简化收费，提高项目兼容性。

将技术难度、风险程度、人力资源消耗相近的项目整合为单个项目收费。

①各种针刀具对病变组织松解剥离，均按“针刀（钩活）疗法”收费，一次部位多次进针的不叠加收费。

②烙具烙烫（各）病变部位，均按“中医烙法”收费。

立项指南价格项目					原价格项目				
项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明	项目名称	计价单位	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
针刀（钩活）疗法	使用针刀、铍针、刃针等各种针刀具，对病变组织松解剥离，起到缓解症状或治疗疾病的作用。	所定价格涵盖定位、穿刺、剥离、包扎等人力资源和基本物质资源消耗。	部位		小针刀治疗	每个部位	85	80	72
					小针刀治疗（刃针治疗）	每个部位	85	80	72
中医烙法	通过烙具烙烫病变部位，起到缓解症状或治疗疾病的作用。	所定价格涵盖定位、消毒、烙烫等人力资源和基本物质资源消耗。	次		扁桃体烙法治疗	次	115	104	88
					鼻中隔烙法治疗	次	115	104	88

★“拨针治疗”指虽也是用于松解剥离粘连组织，但其使用的工具属于钝性微创松解工具，无刀刃，不属于针刀工具，因此不得按照“针刀（钩活）疗法”收费。

根据国家指导意见，“拨针治疗”应按照“特殊针具针法”收费。

2-2. 中医特殊疗法类立项指南项目解读

2. 规范计价单位，防止滥用现象。

将计价单位由“5个穴位”规范为“次”，不以穴位计费，避免滥用现象。

立项指南价格项目					原价格项目				
项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明	项目名称	计价单位	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
点穴疗法	通过对穴位或局部点压施术，起到缓解症状或治疗疾病的作用。	所定价格涵盖定位、施压等人力资源和基本物质资源消耗。	次		手指点穴	5个穴位	26	25	21.3

2-2. 中医特殊疗法类立项指南项目解读

3. 区分难度差异，体现劳务价值。

尊重临床实际，对于技术难度和风险程度较高、人力资源消耗较多的情况，设置“加收项”，体现劳务价值。

项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
针刀（钩活）疗法	使用针刀、铍针、刃针等各种针刀具，对病变组织松解剥离，起到缓解症状或治疗疾病的作用。	所定价格涵盖定位、穿刺、剥离、包扎等人力资源和基本物质资源消耗。	部位		80	76	65
针刀（钩活）疗法 -脊柱针刀疗法（加收）			部位		16	15	13

★针刀(钩活)疗法的计价单位为“部位”，具体指：头部、颈部、胸部、腰部、腹部、臀部、**四肢大关节及手足——单侧手部、单侧足部、四肢单个大关节(肩关节、腕关节、肘关节、髋关节、膝关节、踝关节)**，一次部位多次进针的不叠加收费。

2-2. 中医特殊疗法类立项指南项目解读

4. 明确计价说明，规范临床收费。

明确足底反射疗法，不与中医推拿同时收费。（足底反射疗法可视为推拿的一部分或延伸，因两者都使用按压、揉捏等手法，通过刺激身体特定穴位来达到调理、缓解或治疗作用，因此不与中医推拿同时收费。）

立项指南价格项目					原价格项目				
项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明	项目名称	计价单位	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
足底反射疗法	通过手法对足部反射区进行刺激，起到缓解症状或治疗疾病的作用。	所定价格涵盖泡洗、定位、穴位刺激等人力资源和基本物质资源消耗	次	不与中医推拿同时收费。	足底反射治疗	次	52	50	42.5

2-2. 中医特殊疗法类立项指南项目解读

中国医疗保障 CHINA HEALTHCARE SECURITY

5. 保留传统项目，体现中医特色。

规范整合原有中医传统特色项目予以保留，支持中医传承发展。

立项指南价格项目					原价格项目				
项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明	项目名称	计价单位	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
白内障针拨术	通过拨障针摘除晶状体混浊部分。	所定价格涵盖散瞳、消毒、开睑、切口、拨障针拨断晶状体悬韧带、晶体压入玻璃体腔、出针、闭合切口、包扎等人力资源和基本物质资源消耗。	单眼		白内障针拨术	单眼	364	350	297.5
					白内障针拨吸出术	单眼	585	562.5	478.1
					白内障针拨套出术	单眼	585	562.5	478.1
红皮病清消治疗	针对红皮病病变部位进行清创处理、中药外敷，起到促进皮损愈合的作用。	所定价格涵盖消毒、清创、敷药、包扎等人力资源和基本物质资源消耗。	次		红皮病清消术	次	65	62.5	53.1

虽然在现代医疗发展中“白内障拨针”逐渐被“白内障超声乳化摘除术”取代，但立项指南在编制时，为传承传统医术，支持中医发展，保留此项，为中医在眼科领域的发展提供空间。

★.中医部分项目收费注意事项

1.“普通电针”是否属于仪器针法？

立项指南价格项目					原价格项目				
项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明	项目名称	计价单位	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
常规针法	由主治及以下医师根据病情选穴，通过基本手法和辅助手法，以毫针治疗疾病，促进疏通经络，调理脏腑，扶正祛邪。	所定价格涵盖穴位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针、必要时行**仪器辅助操作等**过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗，含设备投入及维护成本。	次•日	同时采用了常规针法、特殊针具针法、特殊手法针法中的两项或者三项，按收费标准最高的服务项目计费，不叠加计费。儿童加收30%，主任加收40%，副主任加收20%	普通针刺	5个穴位	21	20	17
					微针针刺	次	19.5	18.8	16
					头皮针	次	32.5	31.3	26.6
					针刺运动疗法	次	39	37.5	31.9
					火针	3个穴位	27	26	22
					电针	二个穴位	15.6	15	12.8
					温针	5个穴位	29	27	23
					内热针	5个穴位	43	41	37

不属于。仪器针法是通过各类仪器产生电、热、冷、磁、振动、光等各类效应**替代实体针具**的针刺治疗。应区别于电针、电热针、电冷针、电火针。

普通电针是在使用实体针具基础上，利用**仪器辅助**产生电流刺激代替手法刺激，不属于立项指南所称的“仪器针法”，按“常规针法”收费。

★.中医部分项目收费注意事项

2.“温针灸”如何收费？

“温针灸”在操作技术、服务产出方面与电热针有相似之处，基于立项逻辑一致性的考虑，建议将映射关系调整至“常规针法”，暂按“常规针法”收费，相关易耗品不向患者额外收取费用。

3.“热敏灸”如何收费？

中医灸法类立项指南编制中，经研究论证，“热敏灸”属于“悬空灸”的一种，因此将其映射到“悬空灸”项目中。各地开展“热敏灸”治疗时，可直接按“**悬空灸**”项目收费。

4.“子午流注穴位治疗仪”进行针灸对应哪个项目收费？

“子午流注**穴位治疗仪**”属于应用仪器产生的电、热、冷、磁、振动、光等各类效应**替代针具**完成针法操作的针刺治疗，按“仪器针法”收费。

★注意与“子午流注**开穴法**”区别，采取特殊开穴方法或通过毫针特殊手法治疗的，按“**特殊手法针**法”收费。

★.中医部分项目收费注意事项

5. 中医针法中的特殊穴位如何理解，双侧特殊穴位应当按一个收还是两个收费？

中医特殊穴位针法按“穴位”计价，指单个特殊穴位。如睛明分左右2个穴位，应按两个计价收费；八髎分左右8个穴位，应按8个计价收费——**但我省特殊穴位限制超2个穴位按2个收取★★**。

6. 中医推拿治疗不同疾病，且不同疾病的治疗时间均符合收费标准，是否可分别计价收费？

立项指南坚持以服务产出为价格立项原则，中医推拿立项指南按疾病部位进行价格立项，按疾病**主诊断所属部位**确定收费项目。例如：患者疾病属于“头面部疾病”，但治疗过程中需要推拿头部和肩部的，按“头面部疾病推拿”收费；如患者**同时**患有腰部疾病和颈部疾病（在病历上作出体现），需要进行推拿的，可同时收取“腰部疾病推拿”和“颈部疾病推拿”。

7. 患者进行常规针法治疗或特殊针法治疗时，涉及特殊穴位时如何收费？

医疗机构可在收取“常规针法”或“特殊针法”费用的基础上，按穴位收取“特殊穴位针法”费用。例如：在患者5个常规穴位和2个特殊穴位进行针法治疗，应按“常规针法+特殊穴位针法×2”收费。

★.中医部分项目收费注意事项

8. 关节脱位手法整复能否同时收取骨折手法整复费？

可以。患者**同时**关节脱位和骨折的，医疗机构可据实提供服务，分别收取两项费用。

9. 做了针刀治疗之后，继续采用手法松解治疗，能否同时收费？

可以。两个治疗方式不一致，手法松解是在针刀松解的基础上进一步扩大松解范围，医疗机构需据实做好病历记录。

10. 在彩色多普勒超声引导下做针刀治疗，引导费用可否收取？

可以。医疗机构按照实际操作方式，据实收取“临床操作的彩色多普勒超声引导”，做好病历记录。

11. 中医类项目是否含了中药？

根据中医类相关立项指南的“基本物耗”，都未列明中药属于基本物耗，因此**药品（粉）可以按照药品的相关价格政策，开方计价收费。**

★.中医部分项目收费注意事项

12. 中医骨伤中涉及同一编码有两个项目的，如何传送？

按照市医保中心通知，传送对应项目代码时，增加传送拓展码。

例如：收取“手法整复术（关节脱位）”传送项目代码“014300000010000”+拓展码“0143000000100001”；收取“手法整复术（指（趾）间关节脱位、下颌关节脱位、桡骨头半脱位）”传送项目代码“014300000010000”+拓展码“0143000000100002”。

胎儿彩超-胎儿血流动力学检查的规则一致。

13. 西医医师或者其他医务人员开展中医类项目，是否可以收取相关费用？

可以。医疗服务价格项目可以跨学科使用，具体人员资质建议参照国家卫生健康行业主管部门对医务人员执业范围要求执行。

但是，中医针法类医疗服务价格项目立项指南中明确：（部分项目的服务产出中）所称的“医师”，指具备中医类别执业（助理）医师资格或经培训合格的西学中人员。

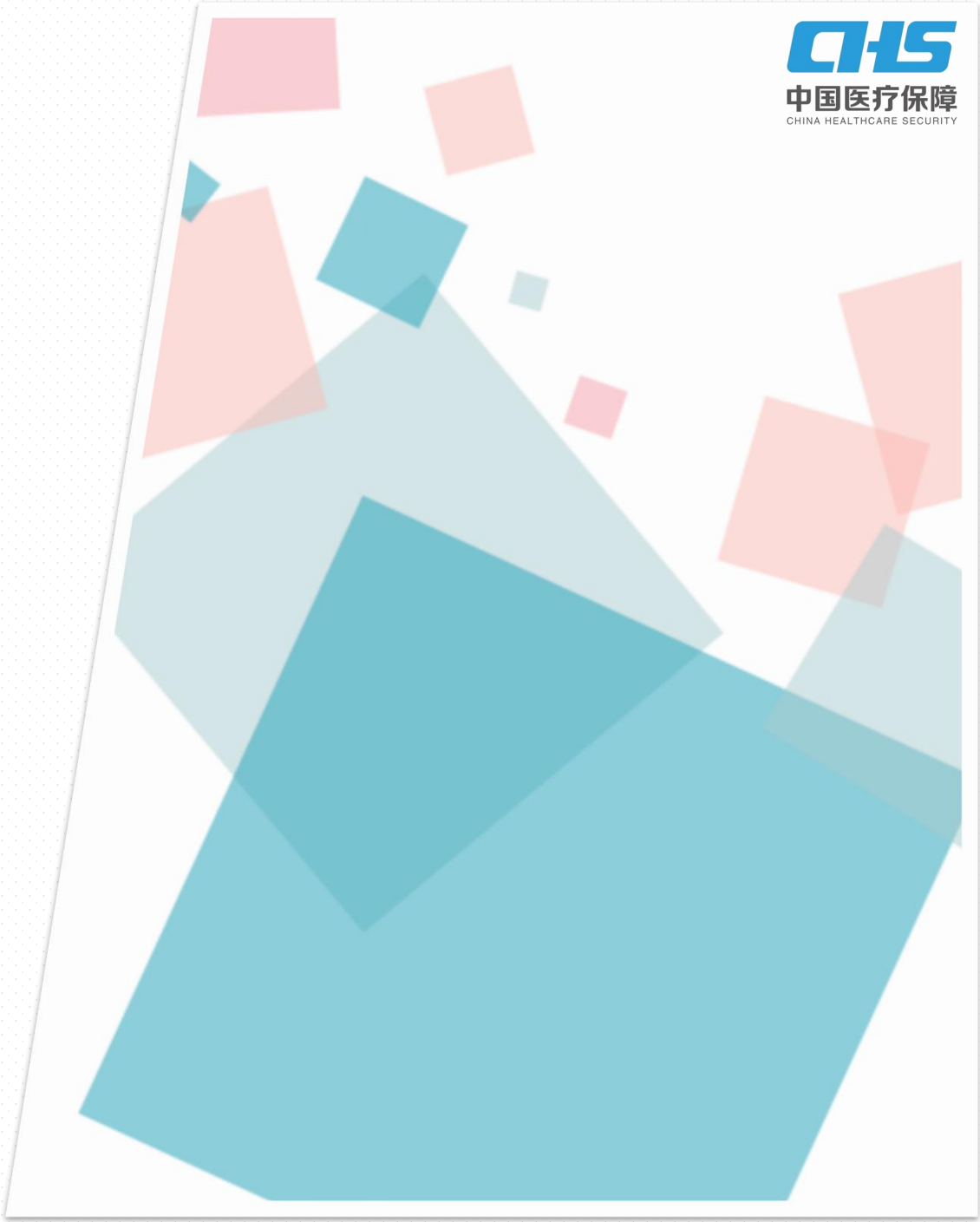
中国医疗保障
CHINA HEALTHCARE SECURITY

PART 3

超声检查类立项指南

3. 超声检查类立项指南

2024年10月，国家医保局印发《超声检查类价格项目立项指南（试行）》，设立13个超声检查类项目。根据国家医保局落实立项指南工作安排，2025年9月8日，省医保局出台了《福建省医疗保障局关于规范整合超声检查类医疗服务价格项目的通知》（闽医保〔2025〕62号），规范整合超声检查类医疗服务价格项目，同时停用我省A型超声检查115项相关价格项目，并要求各地按不高于省属公立医院价格原则制定本地具体项目价格，11月15日起执行。



3-1. 超声检查类立项指南总说明

中国医疗保障
CHINA HEALTHCARE SECURITY

1

本类别以超声检查为重点，**按检查方式的服务产出**设立价格项目。所定价格属于政府指导价为最高限价，下浮不限；同时，医疗机构、医务人员实施超声检查过程中有关创新改良，采取**“现有项目兼容”**的方式简化处理，**无需申报新增医疗服务价格项目，直接按照对应的整合项目执行即可**。

2

“价格构成”，指项目价格应涵盖的各类资源消耗，用于确定计价单元的边界，不应作为临床技术标准理解，不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求。

3

“加收项”，指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时，确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项，实际应用中，同时涉及多个加收项的，以项目单价为基础计算相应的加/减收水平后，据实收费。

4

“扩展项”，指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时，只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项，子项的价格按主项目执行。

3-1. 超声检查类立项指南总说明

5. “基本物耗”指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品，包括但不限于各类消杀用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、垃圾处理用品、润滑剂、护（尿）垫、治疗巾（单）、中单、标签、无菌设备保护套、耦合剂、可复用的操作器具、软件（版权、开发、购买）成本等。基本物耗成本计入项目价格，不另行收费。除基本物耗以外的其他耗材，按照实际采购价格零差率销售。

6. “床旁检查”，指因患者病情危重或无法自行前往检查科室，由检查科室人员移动设备至患者病床旁进行检查。

7. “B型超声检查”和“彩色多普勒超声检查（常规）”中的“部位”，指颅脑、涎腺（含腮腺、颌下腺、引流区淋巴结）、甲状腺（含甲状旁腺、颈部淋巴结）、五官、胸部、腹部（含肝胆胰脾）、胃肠道（含胃、大肠、小肠、肠系膜）、腹膜后（含肾上腺、腹膜后淋巴结）、泌尿系（含肾、输尿管、膀胱、前列腺）、女性生殖系统、男性生殖系统、盆底、乳腺（**双侧**，含引流区淋巴结）、**关节**、体表软组织、**浅表淋巴结**（含颈部、腋窝、腹腔、腹股沟）、周围神经。

可根据临床实际需要开展，但**不得分解**。

★关节具体指：单个大关节（如：肩、肘、腕、髋、膝、踝关节）、颈椎、胸椎、腰椎、单侧手掌部及指间关节、单侧足跖趾及趾间关节、单侧颞颌关节、单侧肩锁关节、胸锁关节。

★应开展双侧超声检查，实际情况中单侧开展的，减半收费。

3-1. 超声检查类立项指南总说明

8. “彩色多普勒超声检查（血管）”和“超声造影（血管）”中的“部位”，指双侧球后血管、双侧颈动脉、双侧锁骨下动脉、双侧椎动脉、腹主动脉、肠系膜动脉、子宫动脉、单侧上肢动脉、单侧下肢动脉、双侧肾动脉、腹腔动脉（含腹腔动脉、脾动脉、肝动脉）、双侧髂动脉、双侧足动脉、双侧颈静脉、单侧上肢静脉、下腔静脉、肝静脉、门脉系统（含门静脉、脾静脉、肠系膜上静脉）、双侧肾静脉、双侧髂静脉、单侧下肢静脉、体表血管、双侧精索静脉等。

9. “对比剂”含药品及非药品类对比剂，非药品类对比剂包含在价格构成中，药品类对比剂按药品管理收费。

10. 涉及的对比分析类检查类项目，可按照实际检查次数收费，例如胆囊和胆道收缩功能检查、膀胱残余尿量检查等，可在出具报告时体现两次检查的不同结论。

11. “人工智能辅助诊断”是指应用人工智能技术辅助进行的超声检查诊断，不得与主项目同时收费。

12. 涉及“包括……”“……等”的，属于开放型表述，所指对象不仅局限于表述中列明的事项，也包括未列明的同类事项。

13. 术中需行各类超声检查的，按本类别中相应项目进行收费，各类引导项目拟在辅助操作立项指南中另行立项。

3-2. 超声检查法类立项指南项目解读

1. 本次超声检查类立项指南，已将出具诊断结果及报告纳入价格构成。

立项指南价格项目					原价格项目				
项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明	项目名称	计价单位	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
A型超声检查	通过A型超声技术，对组织器官进行超声成像及诊断。	所定价格涵盖设备调试、超声检查、数据分析、数据存储、出具诊断结果（含图文报告）等所需的人力资源和基本物质资源消耗。	单侧		A型超声检查	每个部位	4.6	4.4	3.7
					眼部A超	单侧	4.6	4.4	3.7
					超声计算机图文报告	次	7.2	6.5	5.5
多普勒检查（颅内血管）	通过多普勒技术，测定动脉血流方向及速度，对颅底动脉血流动力学进行评价并作出诊断。	所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、获取数据、数据分析、数据存储、出具诊断结果（含图文报告）等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。	次		颅内多普勒血流图（TCD）	次	92	88	74.8
					超声计算机图文报告	次	7.2	6.5	5.5

3-2. 超声检查法类立项指南项目解读

中国医疗保障 CHINA HEALTHCARE SECURITY

2. 统一床旁检查、腔内检查、立体成像等3个加收项目价格。

项目代码	项目名称	计价单位	计价说明	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
012302020010001	B型超声检查-床旁检查(加收)	次	同一次检查中仅加收一次	23	21	18
012302050010001	多普勒检查（周围血管）-床旁检查（加收）	次	同一次检查中仅加收一次	23	21	18
012302050020001	多普勒检查（颅内血管）-床旁检查（加收）	次	同一次检查中仅加收一次	23	21	18
012302030010001	彩色多普勒超声检查（常规）-床旁检查（加收）	次	同一次检查中仅加收一次	23	21	18
012302030020001	彩色多普勒超声检查（心脏）-床旁检查（加收）	次	同一次检查中仅加收一次	23	21	18
012302030030001	彩色多普勒超声检查（血管）-床旁检查（加收）	次	同一次检查中仅加收一次	23	21	18
012302030040001	彩色多普勒超声检查（弹性成像）-床旁检查（加收）	次	同一次检查中仅加收一次	23	21	18
012302030050001	彩色多普勒超声检查（胎儿）-床旁检查（加收）	次	同一次检查中仅加收一次	23	21	18
012302020010011	B型超声检查-腔内检查(加收)	部位		34	32	27
012302030010011	彩色多普勒超声检查（常规）-腔内检查（加收）	部位		34	32	27
012302030050011	彩色多普勒超声检查（胎儿）-腔内检查（加收）	胎·次		34	32	27
012302020010021	B型超声检查-立体成像(加收)	部位		27	24.5	21
012302030010021	彩色多普勒超声检查（常规）-立体成像（加收）	部位		27	24.5	21
012302040010001	超声造影（常规）-立体成像（加收）	器官		27	24.5	21

3-2. 超声检查法类立项指南项目解读

3. 明确床旁检查同一次检查中仅加收一次，不论开展项目是否属于同一收费编码。

项目代码	项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
012302030010000	彩色多普勒超声检查（常规）	通过彩色多普勒超声技术，对组织器官及病灶进行超声成像及诊断。	所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果（含图文报告）等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。	部位	胆囊收缩试验检查全过程按一部位收取	86	82	71
012302030010001	彩色多普勒超声检查（常规）-床旁检查（加收）			次	同一次检查中仅加收一次	23	21	18
012302030020000	彩色多普勒超声检查（心脏）	通过彩色多普勒超声技术（包括M型超声），观察测量心脏及大血管的形态结构、运动状态、血流动力学情况进行综合分析，作出诊断。	所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果（含图文报告）等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。	次		235	220	185
012302030020001	彩色多普勒超声检查（心脏）-床旁检查（加收）			次	同一次检查中仅加收一次	23	21	18

★例如：患者病情需要，需要同时做腹部常规彩超和心脏彩超的床旁检查的，**为同一次检查，只能收一次“床旁检查（加收）”费用。**

3-2. 超声检查法类立项指南项目解读

4. 统一设置人“工智能辅助诊断（扩展）”收费项目，**不得与主项同时收费**。

项目代码	项目名称	计价单位	计价说明	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
012302020010100	B型超声检查-人工智能辅助诊断(扩展)	部位		31	28	24
012302050010100	多普勒检查（周围血管）-人工智能辅助诊断（扩展）	次		54	50	42.5
012302050020100	多普勒检查（颅内血管）-人工智能辅助诊断（扩展）	次		96	92	79
012302030010100	彩色多普勒超声检查（常规）-人工智能辅助诊断（扩展）	部位		86	82	71
012302030020100	彩色多普勒超声检查（心脏）-人工智能辅助诊断（扩展）	次		235	220	185
012302030030100	彩色多普勒超声检查（血管）-人工智能辅助诊断（扩展）	部位		82	78	66
012302030040100	彩色多普勒超声检查（弹性成像）-人工智能辅助诊断（扩展）	器官		100	90	77
012302030050100	彩色多普勒超声检查（胎儿）-人工智能辅助诊断（扩展）	胎·次		145	130	110
012302030060100	彩色多普勒超声检查（胎儿系统性筛查）-人工智能辅助诊断（扩展）	胎·次		295	280	252
012302030070100	彩色多普勒超声检查（胎儿心脏）-人工智能辅助诊断（扩展）	胎·次		235	220	185
012302040010100	超声造影（常规）-人工智能辅助诊断（扩展）	器官		124	117	105
012302040020100	超声造影（血管）-人工智能辅助诊断（扩展）	部位		124	117	105

3-2. 超声检查法类立项指南项目解读

立项指南价格项目								原价格项目	
项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）	项目名称	计价单位
B型超声检查	通过B型超声技术，对组织器官及病灶进行超声成像及诊断。	所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果（含图文报告）等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。	部位		31	28	24	单脏器B超检查	每个脏器
								单脏器B超检查（每增做一个脏器加收）	每个脏器
								胸腹水B超检查及穿刺定位	次
								浅表组织器官B超检查	每个部位
								浅表组织器官B超检查（每增加一个部位加收）	每个部位
								膀胱残余尿量测定	次
								超声计算机图文报告	次
B型超声检查-床旁检查(加收)			次	同一次检查中仅加收一次	23	21	18	床旁超声检查	半小时
								术中床旁超声检查	半小时
B型超声检查-腔内检查(加收)			部位		34	32	27	经阴道B超检查	次
								经直肠B超检查	次
B型超声检查-立体成像(加收)			部位		27	24.5	21		
B型超声检查-排卵监测(减收)			部位		18	16.5	14		
B型超声检查-人工智能辅助诊断(扩展)			部位		31	28	24		

1. 并将不同的计价单位（如每个脏器、每个部位、每次），规范整合为按部位收费。

2. 设置排卵监测（减收）收费项目，满足临床需求。收费为：B型超声检查+B型超声检查-排卵监测(减收)，即：市级31-18=13元/部位。

3-2. 超声检查法类立项指南项目解读

中国医疗保障 CHINA HEALTHCARE SECURITY

立项指南价格项目					原价格项目				
项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明	项目名称	计价单位	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
彩色多普勒超声检查（常规）	通过彩色多普勒超声技术，对组**织器官及病灶**进行超声成像及诊断。	所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果（含图文报告）等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。	部位	**胆囊收缩试验检查全过程按一部位收取**	胸部彩色多普勒超声常规检查	次	88	84	71.4
					腹部彩色多普勒超声常规检查	次	88	84	71.4
					胃肠道彩色多普勒超声常规检查	次	88	84	71.4
					泌尿系彩色多普勒超声常规检查	次	88	84	71.4
					妇科彩色多普勒超声常规检查	次	88	84	71.4
					男性生殖系统彩色多普勒超声常规检查	次	88	84	71.4
					彩色多普勒超声常规检查（腹膜后肿物加收）	次	27.6	26.4	22.4
					彩色多普勒超声常规检查（第二个部位起每部位收）	次	64.4	61.6	52.4
					浅表器官彩色多普勒超声检查	每个部位	84	79.5	67.6
					腹膜后浅表器官彩色多普勒超声检查	每个部位	84	79.5	67.6
					肾上腺浅表器官彩色多普勒超声检查	每个部位	84	79.5	67.6
					超声计算机图文报告	次	7.2	6.5	5.5
彩色多普勒超声检查（常规）-排卵监测（减收）			部位						

1. 将原有明确部位的常规彩超和浅表器官常规彩超，规范整合为“彩色多普勒超声检查(常规)”，并按所规定**部位**收费。（部位规定见说明7）

2. 明确**胆囊收缩试验检查全过程**按一部位收取。**空腹、进食刺激后、餐后**的多次检查为一次完整过程。

3. 设置排卵监测（减收）收费项目，满足临床需求，收费规则同B超。

★延伸问题

加/减收项中的不同编号如何理解?

立项指南中加/减收项对应15位医疗服务项目编码的**最后两位**，简称“加收码”。加收码的第1位代表加/减收的不同类别，加收码的第2位代表同一类别下的不同情况。

★加收码第1位**不同**的**可叠加**收取，加收项第1位**相同**的**不能叠加**收取。例如：“常规针法”中的加收项“01儿童加收”和“11主任医师加收”分属不同类别，可以叠加收费；再如：“体静脉肺动脉吻合费”中的加收项“01双侧吻合”和“02全腔吻合”同属一个类别，不得叠加收费。

★**但是！器官移植、临床量表、中医外治、中医（推拿、灸法、拔罐）、口腔种植、辅助生殖、中医骨伤、产科8批立项指南**加/减收项按自然序列排列，应据实确定是否叠加收费，“阴道分娩”中的加收项“01会阴裂伤修补”和“02宫颈裂伤修补”，不按上述规定执行，临床按实际情况确有必要同时发生的，可叠加计费。

★延伸问题

中国医疗保障
CHINA HEALTHCARE SECURITY

同一价格项目涉及多个加/减收项时，如何计价收费？

如同一价格项目同时涉及多个加/减收项，需以项目单价为基础，分别计算各加/减收项对应的金额后进行汇总收费。

例如：某A项目单价为100元，其中加收项1加收30%(对应金额30元)，加收项2加收40%(对应金额40元)，减收项1减收20%(对应金额20元)，当这些加/减收项同时发生时，最终收费方式统一为：100+100×30%+100×40%−100×20%=150元。

★延伸问题

类型	项目编码	项目名称	价格(市级)
主项目A	012302020010000	B型超声检查	31
减收项A1	012302020010031	B型超声检查-排卵监测（减收）	18
主项目B	012302030010000	彩色多普勒超声检查（常规）	86
减收项B1	012302030010031	彩色多普勒超声检查（常规）-排卵监测（减收）	41
加收项B2	012302030010001	彩色多普勒超声检查（常规）-床旁检查（加收）	34
加收项B3	012302030010011	彩色多普勒超声检查（常规）-腔内检查（加收）	27

1. 医院上传**减收项目**时，（减收项目）**单价为负数**，数量为**正数**，收费项目总金额为负数**（单价×数量）**，若未按规则上传进行系统报错；

2. 收费明细上传减收项目时，**主项目必须上传**，且主项目和减收项目医院审批标志“hosp_appr_flag”需保持一致，不可将主项目与减收项目分开上传或在中途结算时分批上传；

3. 医院上传同一批次的费用明细只能上传**一条主项目和一条减收项目**；若有多个主项目时，**主项目和减收项目需一一对应上传**，即主项目（A）+本项目对应减收项目（A1），主项目（B）+本项目对应减收项目（B1）；

★涉及同一次检查一条主项和多个**不同序列的加/减收项**时，则只需要一条主项，如：主项目（B）+本项目对应减收项目（B1）+本项目对应加收项目（B2）

4. 主项目单价 - 绝对值【减收项目单价】须大于0；例如：B型超声检查排卵监测为：31-18=13元/部位。

3-2. 超声检查法类立项指南项目解读

立项指南价格项目					原价格项目				
项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明	项目名称	计价单位	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
多普勒检查（周围血管）	利用多普勒技术，检测周围**血管形态、血流速度和方向**来评估血管的功能和病变情况，并作出诊断。	所定价格涵盖设备调试、超声测量、获取数据、数据分析、数据储存、出具诊断结果（含图文报告）等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。	次	“多普勒检查（周围血管）”指根据临床需要，多普勒超声对周围血管内皮功能、硬化状态、静脉回流、踝/趾臂指数等指标的检测。	四肢多普勒血流图	单肢			
					多普勒小儿血压检测	次			
					踝肱指数	人次	18	16	14
					超声计算机图文报告	次	7.2	6.5	5.5
多普勒检查（周围血管）-床旁检查（加收）			次	同一次检查中仅加收一次	床旁超声检查	半小时	27.6	26.4	22.4
					术中床旁超声检查	半小时	27.6	26.4	22.4
多普勒检查（周围血管）-人工智能辅助诊断（扩展）			次						

1. 明确“多普勒检查（周围血管）”指根据临床需要，多普勒超声对**周围血管**内皮功能、硬化状态、静脉回流、踝/趾臂指数等指标的检测

2. “踝肱指数”项目未停用，**单独做**踝肱指数（不特指多普勒超声方式）时，仍按“踝肱指数”项目收费。

3-2. 超声检查法类立项指南项目解读

立项指南价格项目					原价格项目				
项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明	项目名称	计价单位	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
多普勒检查（颅内血管）	通过多普勒技术，测定动脉血流方向及速度，对颅底动脉血流动力学进行评价并作出诊断。	所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、获取数据、数据分析、数据存储、出具诊断结果（含图文报告）等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。	次		颅内多普勒血流图（TCD）	次	92	88	74.8
					超声计算机图文报告	次	7.2	6.5	5.5
多普勒检查（颅内血管）-床旁检查（加收）			次	同一次检查中仅加收一次	床旁超声检查	半小时	27.6	26.4	22.4
					术中床旁超声检查	半小时	27.6	26.4	22.4
多普勒检查（颅内血管）-特殊方式检查（加收）			次	特殊方式检查指发泡试验、CO_2试验。					
多普勒检查（颅内血管）-人工智能辅助诊断（扩展）			次						
多普勒检查（颅内血管）-栓子监测（扩展）			次						

1. 明确“多普勒检查（颅内血管）-特殊方式检查（加收）”指发泡试验、CO_2试验。
2. 增设“多普勒检查（颅内血管）-栓子监测（扩展）”，满足临床需求。

3-2. 超声检查法类立项指南项目解读

立项指南价格项目				原价格项目				
项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	项目名称	计价单位	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
彩色多普勒超声检查（心脏）	通过彩色多普勒超声技术（包括M型超声），观察测量**心脏及大血管的形态结构、运动状态、血流动力学情况进行综合分析**，作出诊断。	所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果（含图文报告）等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。	次	心脏彩色多普勒超声	次	114	104	88.4
				普通心脏M型超声检查	次	9.2	8.8	7.5
				普通二维超声心动图	次	36.8	35.2	29.9
				左心功能测定	次	50.6	48.4	41.1
				左心功能测定（增加一项指标加收）	项	7.4	7	6
				声学定量（AQ）	次	46	44	37.4
				彩色室壁动力（CK）	次	46	44	37.4
				组织多普勒显象（TDI）	次	46	44	37.4
				心内膜自动边缘检测	次	46	44	37.4
				室壁运动分析	次	46	44	37.4
				计算机三维重建技术（3DE）	单幅图片	98	88	74.8
				介入治疗的超声心动图监视	半小时	110.4	105.6	89.8
				超声计算机图文报告	次	7.2	6.5	5.5
彩色多普勒超声检查（心脏）-彩色多普勒超声心动图检查（经食管）（扩展）			次	常规经食管超声心动图	次	202.4	193.6	164.6

将心脏彩超相关的**基础结构与形态评估、血流动力学评估、心脏收缩与舒张功能评估、心肌运动与活力评估**规范整合，纳入“彩色多普勒超声检查（心脏）”服务产出。

3-2. 超声检查法类立项指南项目解读

立项指南价格项目					原价格项目				
项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明	项目名称	计价单位	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
彩色多普勒超声检查（血管）	通过彩色多普勒超声技术，对**相关血管进行超声成像及诊断**。	所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果（含图文报告）等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。	部位		颅内段血管彩色多普勒超声	次	113	103	87.6
					球后全部血管彩色多普勒超声	次	113	103	87.6
					颈部血管彩色多普勒超声	次	180	170	145
					颈部血管彩色多普勒超声（颈内静脉加收）	根	18.4	17.6	15
					颈部血管彩色多普勒超声（颈外静脉加收）	根	18.4	17.6	15
					颈部血管彩色多普勒超声（无名静脉加收）	根	18.4	17.6	15
					颈部血管彩色多普勒超声（单做2根）	二根血管	76	71	60.4
					颈部血管彩色多普勒超声（每增加一根加收）	根	18.4	17.6	15
					门静脉系彩色多普勒超声	次	54	51	44
					……	……	……	……	……
					超声计算机图文报告	次	7.2	6.5	5.5

将我省原先颅内段血管彩色多普勒超声、球后全部血管彩色多普勒超声、颈部血管彩色多普勒超声等有具体部位名称的41个血管类超声价格项目及图文报告规范整合成“彩色多普勒超声检查（血管）”，按规定部位收费。（部位规定见**说明8**）

3-2. 超声检查法类立项指南项目解读

立项指南价格项目					原价格项目				
项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明	项目名称	计价单位	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
彩色多普勒超声检查（弹性成像）	通过彩色多普勒超声弹性成像技术，对**病变组织器官及病灶**进行超声弹性成像及诊断。	所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果（含图文报告）等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。	器官		实时剪切波组织弹性成像（SWE）	次	108	97	82.5
					超声计算机图文报告	次	7.2	6.5	5.5
彩色多普勒超声检查（弹性成像）-床旁检查（加收）			次	同一次检查中仅加收一次	床旁超声检查	半小时	27.6	26.4	22.4
					术中床旁超声检查	半小时	27.6	26.4	22.4
彩色多普勒超声检查（弹性成像）-人工智能辅助诊断（扩展）			器官						
彩色多普勒超声检查（常规）	通过彩色多普勒超声技术，对**组织器官及病灶**进行超声成像及诊断。	所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果（含图文报告）等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。	部位	胆囊收缩试验检查全过程按一部位收取					
彩色多普勒超声检查（常规）-腔内检查（加收）									

1. “彩色多普勒超声检查（弹性成像）”调整为按“器官”计价，服务产出明确是对**病变组织器官及病灶**进行超声**弹性成像**及诊断。

2. 与常规彩超成像方式不同，常规彩超检查的部位不一定属于病变组织，**彩超弹性成像无腔内检查加收项**。

3-2. 超声检查法类立项指南项目解读

中国医疗保障 CHINA HEALTHCARE SECURITY

立项指南价格项目					原价格项目				
项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明	项目名称	计价单位	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
彩色多普勒超声检查（胎儿）	通过彩色多普勒超声技术，对胎儿进行超声成像及诊断。	所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、获取数据、数据分析、数据存储、出具诊断结果（含图文报告）等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。	胎·次		产科彩色多普勒超声常规检查	次	88	84	71.4
					产科彩色多普勒超声常规检查（多胎加收）	次	88	84	71.4
					胎儿生物物理相评分	次	27.6	26.4	22.4
					超声计算机图文报告	次	7.2	6.5	5.5
彩色多普勒超声检查（胎儿）-床旁检查（加收）			次	同一次检查中仅加收一次	床旁超声检查	半小时	27.6	26.4	22.4
					术中床旁超声检查	半小时	27.6	26.4	22.4
彩色多普勒超声检查（胎儿）-腔内检查（加收）			胎·次		腔内彩色多普勒超声检查	次	130	118	100.3
彩色多普勒超声检查（胎儿）-人工智能辅助诊断（扩展）			胎·次						
彩色多普勒超声检查（胎儿）-胎儿血流动力学检查（扩展）			**胎·次**	**同时行彩色多普勒超声检查（胎儿）时减半收取。**					
彩色多普勒超声检查（胎儿）-胎儿血流动力学检查（同时行彩色多普勒超声检查）			胎·次						
彩色多普勒超声检查（胎儿）-早孕期筛查（扩展）			胎·次						

含：孕妇子宫动脉、胎儿脐动脉、脐静脉、静脉导管、大脑中动脉等血流速度、方向、阻力等参数。

1. 明确“彩色多普勒超声检查（胎儿）”计价单位为：**胎·次**，即：每个胎儿计价一次。
2. 设置“胎儿血流动力学检查（扩展）”项目，并明确同时行彩色多普勒超声检查（胎儿）时减半收取。即：检查常规胎儿整体情况时候，同时做胎儿血流动力学检查的，收费为：彩色多普勒超声检查（胎儿）+ 彩色多普勒超声检查（胎儿）-胎儿血流动力学检查（同时行彩色多普勒超声检查）。
3. 设置“彩色多普勒超声检查（胎儿）-早孕期筛查（扩展）”项目，满足临床早孕期筛查的需求。

3-2. 超声检查法类立项指南项目解读

立项指南价格项目					原价格项目				
项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明	项目名称	计价单位	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
彩色多普勒超声检查（胎儿系统性筛查）	通过彩色多普勒超声技术，对**胎儿组织器官**进行超声成像及诊断，**排查胎儿结构畸形**等异常情况。	所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果（含图文报告）等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。	胎·次	“彩色多普勒超声检查（胎儿系统性筛查）”指通过彩色多普勒超声对胎儿系统性（神经、呼吸、消化、心血管、脐带胎盘等）**结构性畸形的筛查**及**对胎儿器官发育情况**的检查。	产科彩色多普勒超声常规检查	次	88	84	71.4
					产科彩色多普勒超声常规检查（多胎加收）	次	88	84	71.4
					胎儿生物物理相评分	次	27.6	26.4	22.4
					心脏彩色多普勒超声（胎儿检查）	次	160	148	125.8
					心脏彩色多普勒超声（双胎及以上）	次	206	192	163.2
					超声计算机图文报告	次	7.2	6.5	5.5
彩色多普勒超声检查（胎儿系统性筛查）-可疑胎儿产前诊断（加收）			**胎·次**						
彩色多普勒超声检查（胎儿系统性筛查）-人工智能辅助诊断（扩展）			胎·次						

1. 映射项目无法全部涵盖胎儿系统性筛查的全部内容，该项目属于**新增项目**。
2. 胎儿系统性筛查已涵盖“彩色多普勒超声检查（胎儿）”及扩展项的内容，不得同时收费。
3. 设置“可疑胎儿产前诊断”加收项目，满足临床需求。

3-2. 超声检查法类立项指南项目解读

立项指南价格项目					原价格项目				
项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明	项目名称	计价单位	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
彩色多普勒超声检查（胎儿心脏）	通过各种超声技术，观察测量胎儿心脏及大血管的形态结构、运动状态、血流动力学情况，观测左右心室收缩功能和舒张功能参数，进行综合分析，作出诊断。	所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果（含图文报告）等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。	胎·次		心脏彩色多普勒超声（胎儿检查）	次	160	148	125.8
					心脏彩色多普勒超声（双胎及以上）	次	206	192	163.2
					左心功能测定	次	50.6	48.4	41.1
					左心功能测定（增加一项指标加收）	项	7.4	7	6
					室壁运动分析	次	46	44	37.4
					超声计算机图文报告	次	7.2	6.5	5.5
彩色多普勒超声检查（胎儿心脏）-人工智能辅助诊断（扩展）			胎·次						
彩色多普勒超声检查（胎儿系统性筛查）	通过彩色多普勒超声技术，对**胎儿组织器官**进行超声成像及诊断，**排查胎儿结构畸形**等异常情况。	所定价格涵盖设备调试、体位摆放、超声检查、摄取图像、数据分析、数据存储、出具诊断结果（含图文报告）等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。	胎·次	“彩色多普勒超声检查（胎儿系统性筛查）”指通过彩色多普勒超声对胎儿系统性（神经、呼吸、消化、心血管、脐带胎盘等）**结构性畸形的筛查**及对胎儿器官发育情况的检查。					

1. 胎儿心脏彩超与“彩色多普勒超声检查（心脏）”产出一致，每个胎儿计价一次。
2. 胎儿系统性筛查的胎儿心脏仅需要进行结构性筛查，根据产妇实际，若需要同时做完整的胎儿心脏及大血管的**运动状态、血流动力学及左右心室参数**情况，按规定提供服务的，二者可同时收费。

3-2. 超声检查法类立项指南项目解读

立项指南价格项目					原价格项目				
项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明	项目名称	计价单位	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
超声造影（常规）	通过超声检查，对使用**对比剂**后器官、组织和病灶的大小、形态、回声、血流信息等情况进行成像及分析，并作出诊断。**（不含穿刺/插管）**	所定价格涵盖使用对比剂操作、设备调试、体位摆放、超声动态观察、获取数据、成像、数据分析、数据存储、出具诊断结果（含图文报告）等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。	器官		胃肠充盈造影B超检查	次	32.2	30.8	26.2
					大肠灌肠造影B超检查	次	41.4	39.6	33.7
					输卵管超声造影	次	41.4	39.6	33.7
					胃充盈及排空功能检查	次	23	22	18.7
					小肠充盈及排空功能检查	次	23	22	18.7
					胆囊和胆道收缩功能检查	次	23	22	18.7
					脏器声学造影	次	138	122	103.7
					脏器声学造影（肿瘤声学造影）	次	138	122	103.7
					右心声学造影	次			
					心肌灌注超声检测	次	110.4	105.6	89.8
					超声计算机图文报告	次	7.2	6.5	5.5
超声造影（常规）-立体成像（加收）			器官						
超声造影（常规）-人工智能辅助诊断（扩展）			器官						
超声造影（血管）	通过超声检查，对使用对比剂后血管的形态、血流、血管病变等信息进行成像及分析，并作出诊断。**（不含穿刺/插管）**	所定价格涵盖使用对比剂操作、设备调试、体位摆放、超声动态观察、获取数据、成像、数据分析、数据存储、出具诊断结果（含图文报告）等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。	部位						
超声造影（血管）-人工智能辅助诊断（扩展）			部位						

1. 明确“超声造影（常规）”计价单位为：**器官**；“超声造影（血管）”计价单位为：**部位**。
2. 左右心室、心肌均属于心脏的组成部分，为同一个器官，同一次检查时不得分解收费。
3. “对比剂”含药品及非药品类对比剂，非药品类对比剂包含在价格构成中，药品类对比剂按药品管理收费。

中国医疗保障
CHINA HEALTHCARE SECURITY

PART 4

泌尿系统部分立项指南

4. 泌尿系统部分立项指南

2025年6月13日，国家医保局印发《泌尿系统医疗服务价格项目立项指南（试行）》（医保价采函〔2025〕108号）和《关于开展医疗服务价格规范治理（第五批）的通知》（医保价采函〔2025〕120号），给定血液透析费、血液滤过费、血液透析滤过、血液透析灌流费4个项目规范治理目标价格，7月15日前执行新价格水平。

根据国家医保局工作安排，6月23日，省医保局出台了《关于规范治理泌尿系统部分医疗服务价格项目的通知》（闽医保〔2025〕47号），规范整合泌尿系统部分医疗服务价格项目，设立13项透析治疗相关的医疗服务价格项目，同时停用我省血液透析、血透监测等17项医疗服务价格项目。要求各地按不高于省属公立医院价格原则制定本地具体项目价格，7月15日起执行。

4-1. 泌尿系统部分立项指南总说明

1. “价格构成”指项目价格应涵盖的各类资源消耗，用于确定计价单元的边界，不应作为临床技术标准理解，不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求，价格构成中包含但临床实践中非必要、未发生的，无需强制要求公立医疗机构减计费用。所列“设备投入”包括但不限于操作设备、器具及固定资产投入。

2. “加收项”指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时，确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项，包括在原项目价格基础上增加或减少收费的情况，实际应用中，同时涉及多个加收项的，以项目单价为基础计算相应的加/减收水平后，据实收费。

3. “扩展项”指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时，只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项，子项的价格按主项目执行。

4-1. 泌尿系统部分立项指南总说明

4. “基本物耗”指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品，包括但不限于各类消杀灭菌用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、垃圾处理用品、滑石粉、标签、防渗漏垫、中单、护（尿）垫、棉球、棉签、纱布（垫）、治疗护理盘（包）、治疗巾（单）、手术巾（单）、手术包、普通注射器、可复用的操作器具、冲洗工具、报告打印耗材、碘伏帽、肝素帽、血液透析器、血液透析滤过器、血透管路、血透置换液（成品或自制）、血透透析液以及血液透析、血液滤过等相关操作使用的**其他医用耗材**、软件（版权、开发、购买）成本等。基本物耗成本计入项目价格，不另行收费。除基本物耗以外的其他耗材，按照实际采购价格零差率销售。

穿刺针（含透析用的留置针）、分离器、分离管路

5. 价格构成中所称的**“穿刺”**为主项操作涉及的必要穿刺步骤。

6. 指南中未尽事项，可在辅助操作类等其他立项指南中单独列示，各地医保部门可暂按现行价格项目收费。

指外周静脉或动静脉瘘穿刺，深（中心）静脉穿刺不纳入价格构成。

4-2. 泌尿系统部分项指南项目解读

中国医疗保障 CHINA HEALTHCARE SECURITY

立项指南价格项目					原价格项目					
项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明	项目名称	项目内涵	计价单位	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
血液透析费	通过弥散和对流原理清除血液中过多水分和有害物质。	所定价格涵盖消毒、穿刺、安装设定、连接管路、监测、血液回输、加压止血、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次	本项目中的“监测”指：血温、血压、在线清除率、血容量监测，医院未完成全部四项监测事项的，需按项据实减收，缺1项减收5元。	血液透析	包括碳酸液透析或醋酸液透析	次	400	380	340
					血透监测	含血温、血压、血容量、在线尿素监测	次	20	20	17
血液滤过费	通过对流原理清除血液中过多水分和有害物质。	所定价格涵盖消毒、穿刺、建立通路、抗凝处理、连接管路、补充置换液、清除毒素及水分、监测、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次	本项目中的“监测”指：血温、血压、在线清除率、血容量监测，医院未完成全部四项监测事项的，需按项据实减收，缺1项减收5元。	血液滤过	含透析液、置换液	次	500	500	425
					血透监测	含血温、血压、血容量、在线尿素监测	次	20	20	17
血液透析滤过费	通过同时进行血液透析和血液滤过清除血液中过多水分和有害物质。	所定价格涵盖消毒、穿刺、建立通路、连接管路、参数设置、清除毒素及水分滤过、监测、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次	本项目中的“监测”指：血温、血压、在线清除率、血容量监测，医院未完成全部四项监测事项的，需按项据实减收，缺1项减收5元。	血液透析滤过	含透析液、置换液	次	600	600	510
					血透监测	含血温、血压、血容量、在线尿素监测	次	20	20	17
血液透析灌流费	通过同时进行血液透析和血液灌流清除血液中过多水分和有害物质。	所定价格涵盖消毒、穿刺、建立通路、连接管路、参数设置、透析灌流、监测、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次	本项目中的“监测”指：血温、血压、在线清除率、血容量监测，医院未完成全部四项监测事项的，需按项据实减收，缺1项减收5元。	血液灌流	含透析、透析液	次	500	500	425
					血透监测	含血温、血压、血容量、在线尿素监测	次	20	20	17

1. **血温、血压、在线清除率、血容量**四项监测被明确纳入项目价格构成。医院未完成全部四项监测事项的，需按项据实减收，每缺1项减收5元。

2. 穿刺、封管等必经步骤不得拆分收费。

4-2. 泌尿系统部分项指南项目解读

立项指南价格项目					原价格项目					
项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明	项目名称	项目内涵	计价单位	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
血液灌流费	通过吸附原理直接结合血液中的中大分子及蛋白结合毒素。	所定价格涵盖消毒、穿刺、建立通路、连接管路、参数设置、血液灌流、回输、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次		拆分我省原“血液灌流”项目，独立设置灌流项目。					
血液透析灌流费	通过同时进行**血液透析和血液灌流**清除血液中过多水分和有害物质。	所定价格涵盖消毒、穿刺、建立通路、连接管路、参数设置、透析灌流、监测、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次	本项目中的“监测”指：血温、血压、在线清除率、血容量监测，医院未完成全部四项监测事项的，需按项据实减收，缺1项减收5元。	血液灌流	含透析、透析液	次	500	500	425
					血透监测	含血温、血压、血容量、在线尿素监测	次	20	20	17

1. “血液灌流费”为我省原“血液灌流（含透析）”拆分，对中毒及中大分子及蛋白结合毒素患者仅实施血液灌流治疗，独立设置的项目。
2. “血液透析灌流费”则完全映射我省原“血液灌流”，并把监测费用纳入项目价格构成。
3. **灌流器**维持原有政策，按照零差率销售除外收费，纳入医保支付范围。
4. 透析器、管路、穿刺针、透析液等说明4所列“基本物耗”均纳入价格构成。

4-2. 泌尿系统部分项指南项目解读

立项指南价格项目								原价格项目					
项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）	项目名称	项目内涵	计价单位	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
血浆置换费	分离血浆、用置换液置换含有有害物质的血浆。	所定价格涵盖消毒、穿刺、连接管路、血浆分离置换、回输、去除装置、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次		2450	2325	2000	血浆置换术	机采	次	2000	2000	1700

1. 分离管路和分离器维持原政策，纳入价格构成，不得另行收费。
2. 考虑项目成本问题，结合调价方案，按不高于省级价格原则给予提高价格。

4-2. 泌尿系统部分项指南项目解读

立项指南价格项目								原价格项目					
项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）	项目名称	项目内涵	计价单位	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
连续性肾脏替代治疗费	通过血液净化实现连续肾脏替代治疗和多脏器功能衰竭的生命支持治疗。	所定价格涵盖消毒、穿刺、连接管路、上机、血液净化、体外抗凝、回输、去除装置、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	小时	连续性肾脏替代治疗使用的**滤器、管路**按零差率销售价格另行收取相应费用，纳入医保支付范围。	95	95	86	连续性血液净化		小时	80	80	68
								连续性血液净化（重症监护室）		小时	180	180	153
连续性肾脏替代治疗费-连续性血浆吸附滤过治疗（加收）			小时		28	28	25	连续性血浆滤过吸附		次	200	200	170

1. 整合两个连续性血液净化项目，不再区分治疗场景，统一设置为“连续性肾脏替代治疗费”。
2. 将**管路、滤器**从项目价格构成中剥离，按零差率销售价格另行收取相应费用，纳入医保支付范围。
3. 连续性血浆吸附滤过治疗设置为加收项目，更符合临床实际开展情况。

4-2. 泌尿系统部分项指南项目解读

中国医疗保障 CHINA HEALTHCARE SECURITY

滤过器类和管路类医用耗材国家编码政策标识表						
项目编码	项目名称	除外耗材名称	耗材代码_15	医保属性	医保最高支付限额（泉州）	个人先行自付比例
013110000080000	连续性肾脏替代治疗费	滤过器类	C10040116700000	医保	5000元	
013110000080000	连续性肾脏替代治疗费	滤过器类	C10050116700000	医保	5000元	
013110000080000	连续性肾脏替代治疗费	管路类	C10040201000000	医保	5000元	
013110000080000	连续性肾脏替代治疗费	管路类	C10040301000000	医保	5000元	
013110000080000	连续性肾脏替代治疗费	管路类	C10050201000000	医保	5000元	
013110000080000	连续性肾脏替代治疗费	管路类	C10060101000000	医保	5000元	
013110000080000	连续性肾脏替代治疗费	管路类	C10060201000000	医保	5000元	

目前**CRRT（连续性肾脏替代治疗）**主要包括以下技术：

（前7根据国家卫健委印发的血液净化标准操作规程（2021）版）

1. 缓慢连续超滤(Slow Continuous Ultrafiltration, SCUF)
2. 连续性静脉-静脉血液滤过(Continuous Venovenous Hemofiltration, CVVH)
3. 连续性静脉- 静脉血液透析滤过(Continuous Venovenous Demodiafiltration, CVVHDF)
4. 连续性静脉-静脉血液透析(Continuous Venovenous Hemodialysis, CVVHD)
5. 连续性高通量透析(Continuous High Hlux Dialysis, CHFD)
6. 连续性高容量血液滤过(High Volume Hemofiltration, HVHF)
7. 连续性血浆滤过吸附(Continuous Plasma Filtration Adsorption, CPFA)
8. 连续性动脉-静脉血液滤过 (Continuous Arteriovenous Hemofiltration, CAVH) ——早期的经典动静脉模式
9. 连续性动脉- 静脉血液透析(Continuous Arteriovenous Hemodialysis, CAVHD) ——早期的经典动静脉模式

4-2. 泌尿系统部分项指南项目解读

立项指南价格项目					原价格项目					
项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明	项目名称	项目内涵	计价单位	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
腹膜透析费（人工）	通过人工进行肾脏替代治疗清除毒素和/或水分。	所定价格涵盖操作前准备、透析管连接、注入透析液、引流液收集、记录等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次		腹膜透析换液	含腹透液加温、加药、腹透换液操作及培训	次	15	15	12.8
腹膜透析费（自动）	通过设备进行肾脏替代治疗清除毒素和/或水分。	所定价格涵盖设备准备、透析管连接、设备运行、引流液收集、记录等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	小时		腹透机自动腹膜透析		小时	15	15	12.8
腹膜平衡试验费	对腹膜功能进行检测，调整腹膜透析方案。	所定价格涵盖腹透换液、留取标本、测量、计算、出具方案、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次		腹膜平衡试验	含定时、分段取腹腔液；不含化验检查	次	40	40	34

与我省原有项目一对一映射。

4-2. 泌尿系统部分项指南项目解读

中国医疗保障 CHINA HEALTHCARE SECURITY

立项指南价格项目								原价格项目					
项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	计价说明	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）	项目名称	项目内涵	计价单位	价格（市级）	价格（县级）	价格（基层）
腹膜透析置管费	通过各种方式放置腹膜透析导管。	所定价格涵盖消毒、切开、穿刺或分离、置管、试水通畅、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次	使用腹腔镜辅助操作市级加收625元，县级加收600元，基层加收510元。	400	400	340	腹膜透析置管术	包括拔管术	次	400	400	340
								经腹腔镜腹膜透析置管术		次	1025	1000	850
腹膜透析换管费	更换破损、堵塞、移位的腹膜透析导管。	所定价格涵盖消毒、切开、拔除旧管、原位置入新管、试水通畅、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次	不与“腹膜透析置管费”“腹膜透析导管取出费”“腹膜透析导管感染清创费”同时收取。**更换外管**市、县级按40元收取，基层按34元收取。	420	420	360	腹膜透析换管		次	40	40	34
腹膜透析导管取出费	通过各种方式取出腹膜透析导管。	所定价格涵盖消毒、切开、分离、拔管、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次	使用腹腔镜辅助操作市级加收625元，县级加收600元，基层加收510元。	400	400	340	腹膜透析置管术(拔管术)		次	400	400	340
								经腹腔镜腹膜透析置管术(拔管术)		次	1025	1000	850

1. 目前，腹腔镜使用费据实收费，腔镜使用费的相关立项指南落地文件出台后，则根据新规定执行。

2. “腹膜透析换管费”位更换腹膜透析导管（内管），**更换外管**市、县级按40元收取，基层按34元收取。

★.其他相关问题

1. 立项指南中哪些项目设置儿童加收政策?

2012年，国家发展改革委、卫生部、国家中医药管理局《关于规范医疗服务价格管理及有关问题的通知》（发改价格〔2012〕1170号）规定了儿童加收政策的基本范围和水平，即“有创活检和探查、临床手术治疗（含麻醉）等项目执行6岁以下儿童加收政策，加收比例不超过30%”。

立项指南所称“儿童”，指6周岁及以下。6周岁以下，应当以公历的7周岁生日当天作为边界，7周岁生日的第二天起不得再收取儿童加收费用。即：**出生至7周岁生日当天属于儿童加收政策范围**。例如：患者2020年1月1日出生，2027年1月2日0时后不应再执行儿童加收政策。

★.其他相关问题

中国医疗保障
CHINA HEALTHCARE SECURITY

2. 除使用说明中已经明确的计价单位外，医疗机构是否可以按照“其他”增加收费部位?

不可以。

立项指南中，关于项目的计价部位已经明确的，医疗机构不能参考“其他”增加收费部位/血管/脏器。

例如：“X线摄影成像”中，踝关节属于单侧下肢的一部分，踝关节不得按“其他”进行收费。

再如：目前“彩色多普勒超声检查（血管）”未列明双侧锁骨下静脉的计价部位，双侧锁骨下静脉不得按“其他”或“等”进行增加收费部位。行双侧锁骨下静脉多普勒检查时，医疗机构暂按“多普勒检查（周围血管）”收费，待国家进一步规范后另行通知。

★.其他相关问题

3. 放射检查中云影像给不了要减5元，按部位算还是按次数算?

根据国家最新精神，执行按单个放射检查项目减收，与部位、体位数量无关。每个独立的放射检查项目若无法提供云影像服务，如一次CT检查或一次MRI检查需减收5元。

每个独立的放射检查项目减收金额按检查次数固定为5元，不按检查涉及的部位、体位数量重复计算减收。

若**两个独立项目同时检查的，需按照独立项目条目数量累计减收**，例如：同一次检查中，做了“颈椎”的CT平扫和“颅脑”的CT增强扫描，收费为“计算机体层成像（CT）平扫”和“计算机体层成像（CT）增强”两个独立项目，无法提供云影像的，需减收5×2=10元。

★.其他相关问题

中国医疗保障
CHINA HEALTHCARE SECURITY

4. 立项指南映射关系是否可以作为直接收费依据算?

不可以。

立项指南映射关系是根据诊疗服务的服务产出及价格构成，在立项指南与现行医疗服务项目及卫生技术规范之间建立的关联映射，是各地医疗保障部门制定价格、医疗机构在面对新老衔接过程中，便于计价收费的参考。

收费严格按照服务产出、价格构成、计价说明的规定。

★.其他相关问题

5. 临床量表类立项指南中自评与他评是否可以同时计费？

可以。临床量表评估的自评与他评，不论是否属于同一学科，临床在开展相关医疗服务时，可根据量表自评或他评的情况，分别计费。

6. “B 型超声检查”和“彩色多普勒超声检查(常规）”中的“部位”，如：浅表淋巴结（含颈部、腋窝、腹腔、腹股沟），是否需要全部做完？

不需要，临床根据患者实际病情做好病历记录，开展相关部位淋巴结检查即可。

另外，例如立项指南中已经明确腹部是包含肝胆胰脾四个脏器的，如患者病情确实只需要开展单脏器检查，医疗机构按需提供服务的，也可按照一个部位收取相关费用。**做好病历记录，但切勿刻意分解收费！！**

7. 透析立项指南中使用说明基本物耗“血透置换液(成品或自制)、血透透析液”，是否仅指用于血液滤过、血液透析滤过的血透置换液？

血浆置换费、血浆吸附费（福建未立项）、连续性肾脏替代治疗费项目价格构成**不含**透析液、置换液。其余血液透析类项目使用的透析液、置换液已计入项目价格构成。

问题解答

1. 拔罐治疗按次数收费，是针对一个疾病，那有的病人有多个疾病，那还是只能收一次费用，还是可以收两次，因为不同部位不同疾病？涉及不同罐法治疗的呢？

答：“中医拔罐”按次收费，指的是单次治疗，不区分疾病及部位。若同一次涉及不同的罐法治疗，按对应的罐法分别收费即可，例如：同一次治疗中，同时提供走罐和闪罐治疗服务，可同时收取“中医走罐”和“中医闪罐”费用。

2. 颈椎病、腰痛患者，不同部位做悬空灸、隔物灸，可以同时收费吗？

答：“悬空灸”、“隔物灸”为两个独立项目，按次收费，同一次诊疗中医疗机构按照服务产出提供相应服务的，据实收费即可，无关部位。

3. 腰椎间盘突出症 患者腰部及患侧臀部酸痛伴患侧下肢麻木。针刀松解腰部、患侧臀部及下肢。请问收1个部位还是3个部位？

答：按照“针刀（钩活）疗法”的计价单位，腰部、臀部、下肢（足）可分别计价。

问题解答

4. 请问肌肉按什么项目收费，是否可以按区域计费？如：上臂肌肉、前臂肌肉、臀部肌肉按部位收？一个区域的肌肉数目包含多个，如臀部肌肉的肌肉损伤和肌炎包含的肌肉有：臀大肌、臀小肌、梨状肌、上孖肌、下孖肌、股方肌等，扫查也费时。。

答：按照“B型超声检查”和“彩色多普勒超声检查（常规）”中“部位”的“体表软组织”收费，单次检查中，无论需要检查多少肌肉组织，均按一个“体表软组织”收取一次费，不得自行扩大。

5.（超声）床边检查时，如果同一个病人做了两个部位彩超，但不同医生去做的，床边收费可以收两次吗？如果同一个病人一天内多次呼叫床边，但同一个医生去做，可以按次数收床边吗？

答：（超声）床旁检查同一次检查中仅加收一次，不论开展项目是否属于同一收费编码，也无论开展的医生是否同一个。若一天内开展多次床旁（超声）检查，按实际检查次数加收即可，但不得恶意分解！

问题解答

6. 一个部位做腹部常规彩超，另一个部位做阴道常规彩超，是彩色多普勒收两次费用+一次加腔内加收吗？

答：是的。按照对应部位收取“彩色多普勒超声检查（常规）”费用，再收取对应部位的“彩色多普勒超声检查（常规）-腔内检查（加收）”费用，即：彩色多普勒超声检查（常规）×2+彩色多普勒超声检查（常规）-腔内检查（加收）×1。

7. 颈部动脉（彩超）正常是双侧颈动脉跟双侧椎动脉+双侧锁骨下动脉一起做，那这个怎么收费？

答：按照对应的部位“双侧颈动脉、双侧锁骨下动脉、双侧椎动脉”收取3个部位相关费用即可。

THANK YOU!

感谢聆听